Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 07:36
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 07:37
Temps mis	1 min 23 s
Points	3,40/23,00
Note	**2,96** sur 20,00 (**14,78**%)

Question 1

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant la pharmacologie chez le sujet âgé :

- a. Les modifications des fonctions rénales impliquent une adaptation de posologie. ✔
- b. La demi-vie plasmatique des médicaments est diminuée par rapport à l'adulte jeune. ✖
- c. Une hypoalbuminémie peut être associée à un surdosage des certains médicaments. ✔
- d. L'effet de premier passage hépatique est majoré par rapport à l'adulte jeune. ✖
- e. Le volume de distribution des médicaments liposolubles est diminué par rapport à l'adulte jeune. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Les modifications des fonctions rénales impliquent une adaptation de posologie., Une hypoalbuminémie peut être associée à un surdosage des certains médicaments.

Question 2

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant la pharmacocinétique chez le nouveau-né (par rapport à l'adulte) :

- a. Le volume de distribution est diminué. ✖
- b. L'excrétion rénale est accrue, ce qui augmente la clairance rénale. ✖
- c. La barrière hémato encéphalique est immature. ✔
- d. Les T1/2 (demi-vie) d'élimination des médicaments sont augmentées. ✔
- e. Les CYP450 hépatiques sont exprimés à des niveaux constants en période de périnatalité. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : La barrière hémato encéphalique est immature., Les T1/2 (demi-vie) d'élimination des médicaments sont augmentées.

Question 3

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant la pharmacocinétique :

- a. La demi-vie plasmatique dépend uniquement du volume de distribution.
- b. La demi-vie plasmatique dépend de la biodisponibilité. ✖
- c. La demi-vie plasmatique dépend de la clairance et du volume de distribution.
- d. La demi-vie plasmatique dépend de la clairance et de la biodisponibilité.
- e. La demi-vie plasmatique dépend de la posologie.

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : La demi-vie plasmatique dépend de la clairance et du volume de distribution.

Question 4

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Lors d'une administration répétée et régulière, l'équilibre de concentration plasmatique d'un médicament est atteint :

- a. Au bout de 4 intervalles tau ✖
- b. Au bout de 5 demi-vies du médicament ✔
- c. Lorsque les valeurs de Cmax sont identique après chaque prise du médicament ✔
- d. Lorsque les valeurs de Cmax et Cmin sont comprises dans l'intervalle thérapeutique. ✖
- e. Lorsque la clairance d'élimination devient constante ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Au bout de 5 demi-vies du médicament, Lorsque les valeurs de Cmax sont identique après chaque prise du médicament

---

Question 5

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant le suivi thérapeutique pharmacologique :

- a. Il est recommandé pour certains médicaments immunodépresseurs. ✔
- b. Il est obligatoire pour les anticoagulants de la famille des anti-vitamine K (AVK). ✖
- c. Il est justifié si l'index thérapeutique est étroit. ✔
- d. Il est nécessaire pour les anti inflammatoires non-stéroïdiens. ✖
- e. Il est utile pour individualiser le traitement par des anti-cancéreux inhibiteurs de récepteurs à activité tyrosine kinase. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Il est recommandé pour certains médicaments immunodépresseurs., Il est justifié si l'index thérapeutique est étroit., Il est utile pour individualiser le traitement par des anti-cancéreux inhibiteurs de récepteurs à activité tyrosine kinase.

Question 6

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant la variabilité de l'effet des médicaments :

- a. On retrouve des variabilités interindividuelles. ✔
- b. Elle peut être due à des interactions médicamenteuses. ✔
- c. Elle augmente de façon proportionnelle à l'âge. ✖
- d. On retrouve l'impact de la consommation d'alcool et de tabac. ✔
- e. Elle dépend uniquement du fond génétique de l'individu. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : On retrouve des variabilités interindividuelles., Elle peut être due à des interactions médicamenteuses., On retrouve l'impact de la consommation d'alcool et de tabac.

Question 7

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant la variabilité de l'effet des médicaments liée aux enzymes du métabolisme :

- a. On parle de métaboliseurs lents. ✔
- b. On parle de métaboliseurs anormaux. ✖
- c. On parle de métaboliseurs rapides. ✔
- d. On parle de l'effet inhibiteur enzymatique du tabac. ✖
- e. On parle de l'effet inhibiteur enzymatique du jus de pamplemousse. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : On parle de métaboliseurs lents., On parle de métaboliseurs rapides., On parle de l'effet inhibiteur enzymatique du jus de pamplemousse.

Question 8

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

A propos de la toxicité associée à la prise de paracétamol :

- a. Le métabolite toxique du paracétamol est sulfoconjugué. ✖
- b. La toxicité est augmentée en cas de prise aiguë d'alcool. ✔
- c. La détoxification implique la glutathion S transférase. ✔
- d. La toxicité du paracétamol implique sa biotransformation en N-AcétylParabenzoQuinone-Imine. ✔
- e. Les métabolites toxiques du paracétamol induisent une cytolyse pancréatique avec ulcération gastro-intestinale. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : La toxicité est augmentée en cas de prise aiguë d'alcool., La détoxification implique la glutathion S transférase., La toxicité du paracétamol implique sa biotransformation en N-AcétylParabenzoQuinone-Imine.

Question 9

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant les essais cliniques de phase I :

- a. Ils permettent de mesurer la dose maximale tolérée sur des sujets sains sans comorbidité. ✔
- b. Ils visent à identifier la dose minimale avec des effets nocifs observables (LOAEL). ✔
- c. Ils visent à identifier la dose minimale létale. ✖
- d. Ils sont réalisés sur des animaux. ✖
- e. Ils permettent de mesurer la distribution du principe actif au sein de chaque organe. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Ils permettent de mesurer la dose maximale tolérée sur des sujets sains sans comorbidité., Ils visent à identifier la dose minimale avec des effets nocifs observables (LOAEL).

Question 10

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant les essais cliniques de phase II :

- a. Ils indiquent l'efficacité du candidat médicament. ✖
- b. Ils permettent de repérer des effets indésirables éventuels. ✔
- c. Ils permettent de déterminer la dose thérapeutique optimale d'un médicament chez des patients. ✔
- d. Ils permettent d'optimiser la posologie du médicament. ✔
- e. Ils correspondent à des essais comparatifs croisés. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.

Les réponses correctes sont : Ils permettent de repérer des effets indésirables éventuels., Ils permettent de déterminer la dose thérapeutique optimale d'un médicament chez des patients., Ils permettent d'optimiser la posologie du médicament.

Question 11

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

A propos des essais cliniques de phases III :

- a. Le critère de jugement principal est un critère clinique. ✔
- b. Ils comparent des patients à des sujets sains. ✖
- c. Ce sont des essais comparatifs, randomisés, avec procédure d'insu. ✔
- d. Ils sont réalisés en vue de démontrer l'efficacité du candidat médicament. ✔
- e. Ils sont réalisés en vue d'établir le rapport des risques sur les bénéfices R/B. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Le critère de jugement principal est un critère clinique., Ce sont des essais comparatifs, randomisés, avec procédure d'insu., Ils sont réalisés en vue de démontrer l'efficacité du candidat médicament.

Question 12

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

A propos des cytochromes P450 :

- a. Ce sont des enzymes de la famille des transférases. ✖
- b. Ils sont tous exprimés dès la naissance. ✖
- c. Leur activité est modulée par des aliments. ✔
- d. Leur activité catalytique varie selon des polymorphismes génétiques. ✔
- e. Leur expression est constante et ubiquiste. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Leur activité est modulée par des aliments., Leur activité catalytique varie selon des polymorphismes génétiques.

Question 13

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

A propos des composés toxiques :

- a. La toxicité peut résulter de l'effet additif de l'exposition à plusieurs composés à des doses individuelles non dangereuses. ✔
- b. Les toxiques environnementaux sont biotransformés par des voies similaires à celles des médicaments. ✔
- c. Les combinaisons de xénobiotiques peuvent avoir des effets cocktails. ✔
- d. Les xénobiotiques sont tous des composés toxiques. ✖
- e. La toxicité peut être aiguë ou chronique. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : La toxicité peut résulter de l'effet additif de l'exposition à plusieurs composés à des doses individuelles non dangereuses., Les toxiques environnementaux sont biotransformés par des voies similaires à celles des médicaments., Les combinaisons de xénobiotiques peuvent avoir des effets cocktails., La toxicité peut être aiguë ou chronique.

Question 14

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant le métabolisme des xénobiotiques :

- a. Les réactions d'hydrolyse font partie de la phase II. ✖
- b. Les réactions de transfert font partie de la phase I. ✖
- c. L'acétylation est une réaction de phase I. ✖
- d. La glucuronoconjugaison est une réaction de phase II. ✔
- e. La métabolisation de xénobiotique est une voie de détoxification. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : La glucuronoconjugaison est une réaction de phase II., La métabolisation de xénobiotique est une voie de détoxification.

Question 15

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Concernant la pharmacogénétique :

- a. Elle s'intéresse aux polymorphismes des gènes codant des cibles des médicaments. ✔
- b. Les métaboliseurs rapides présentent entre autres un nombre excessif d'allèles sauvages de gènes codant des enzymes de biotransformation. ✔
- c. Les métaboliseurs lents présentent entre autres des duplications de gènes codant des enzymes de biotransformation. ✖
- d. Elle est étudiée dès la phase clinique II du développement d'un médicament. ✔
- e. Elle consiste entre autres à identifier les mutations de cibles de thérapies anticancéreuses. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Elle s'intéresse aux polymorphismes des gènes codant des cibles des médicaments., Les métaboliseurs rapides présentent entre autres un nombre excessif d'allèles sauvages de gènes codant des enzymes de biotransformation., Elle est étudiée dès la phase clinique II du développement d'un médicament., Elle consiste entre autres à identifier les mutations de cibles de thérapies anticancéreuses.

Question 16

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, lesquelles correspondent à la phase vasculo-exsudative de la réaction inflammatoire ?

- a. Elle se subdivise en deux temps : l'exsudation et la phase cellulaire ✖
- b. L'histamine joue un rôle important au stade initial. ✔
- c. Elle se déroule initialement dans un tissu conjonctif vascularisé. ✔
- d. Elle est immédiatement suivie par la diapédèse leucocytaire. ✖
- e. Elle contribue à la formation de l'oedème inflammatoire. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : L'histamine joue un rôle important au stade initial., Elle se déroule initialement dans un tissu conjonctif vascularisé., Elle contribue à la formation de l'oedème inflammatoire.

Question 17

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant les marqueurs de l'inflammation :

- a. La mesure de la VS (vitesse de sédimentation) constitue l'un des marqueurs classique spécifique du syndrome inflammatoire. ✖
- b. Les principaux marqueurs de l'inflammation utilisés en diagnostique sont des protéines qui participent directement à la défense de l'organisme. ✔
- c. Ils ont pour caractéristique d'avoir une cinétique de variation rapide avec une amplitude forte (de 100 à 1000X). ✖
- d. Les marqueurs à cinétique moyenne ou lente ne présentent aucun intérêt pour le suivi du statut inflammatoire d'un patient. ✖
- e. L'orosomucoïde est un marqueur précoce de la réaction inflammatoire. ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Les principaux marqueurs de l'inflammation utilisés en diagnostique sont des protéines qui participent directement à la défense de l'organisme.

Question 18

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Concernant l'inflammation granulomateuse :

- a. Elle est caractérisée par la prédominance de la réaction cellulaire. ✔
- b. Après quelques jours d'évolution, le tissu de granulation inflammatoire s'enrichi de polynucléaires et de leucocytes mononuclées au sein d'une matrice extra cellulaire œdémateuse. ✔
- c. Au sein du granulome inflammatoire, les macrophages se différencient en monocytes capables de phagocytose. ✖
- d. C'est une inflammation productive caractérisée par la prolifération de fibroblastes. ✔
- e. Elle permet d'assurer la détersion du foyer lésionnel par les phagocytes. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Elle est caractérisée par la prédominance de la réaction cellulaire., Après quelques jours d'évolution, le tissu de granulation inflammatoire s'enrichi de polynucléaires et de leucocytes mononuclées au sein d'une matrice extra cellulaire œdémateuse., C'est une inflammation productive caractérisée par la prolifération de fibroblastes., Elle permet d'assurer la détersion du foyer lésionnel par les phagocytes.

Question 19

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Concernant l'inflammation chronique :

- a. Elle se caractérise par des phénomènes vasculo-exsudatifs intenses faisant suite à une agression brève du tissu conjonctif vascularisé. ✖
- b. Une réaction inflammatoire peut se manifester d'emblée sous une forme chronique, la phase aiguë vasculo-exsudative passant alors inaperçue, étant brève et/ou asymptomatique. ✔
- c. Elle n'a aucune tendance à la guérison spontanée. ✔
- d. Elle peut être causée par une détersion incomplète. ✔
- e. Une infection par le VHB (Virus de l'hépatite B) peut être la cause d'une hépatite chronique. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Une réaction inflammatoire peut se manifester d'emblée sous une forme chronique, la phase aiguë vasculo-exsudative passant alors inaperçue, étant brève et/ou asymptomatique., Elle n'a aucune tendance à la guérison spontanée., Elle peut être causée par une détersion incomplète., Une infection par le VHB (Virus de l'hépatite B) peut être la cause d'une hépatite chronique.

Question 20

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant la détersion lors de la réaction inflammatoire :

- a. Elle succède progressivement à la phase vasculo-exsudative et est contemporaine de la phase cellulaire. ✔
- b. Les phagocytes participent au processus d'élimination des tissus nécrosés. ✔
- c. Le processus de cicatrisation du tissu lésé n'intervient qu'après détersion complète. ✖
- d. La détersion externe permet d'éliminer systématiquement le matériel nécrosé liquéfié (pus, caséum) par fistulisation à la peau ou dans un conduit (bronchique, urinaire, intestinal...). ✖
- e. Elle s'accompagne d'une production de dérivés oxygénés toxiques pouvant entrainer une altération des tissus sains. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Elle succède progressivement à la phase vasculo-exsudative et est contemporaine de la phase cellulaire. , Les phagocytes participent au processus d'élimination des tissus nécrosés., Elle s'accompagne d'une production de dérivés oxygénés toxiques pouvant entrainer une altération des tissus sains.

Question 21

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant la CRP (Protéine C réactive) :

- a. C'est une Protéine de la réaction inflammatoire (PRI) qui évolue parallèlement à celle du fibrinogène. ✖
- b. C'est une protéine faisant partie du système du complément. ✖
- c. Elle agit comme une opsonine. ✔
- d. Au cours de la réaction inflammatoire, son taux augmente dès la 6ème heure pour atteindre son maximum au bout de 24 à 48h. ✔
- e. En clinique, sa seule mesure permet la détection des infections bactérienne en période prénatale et néonatale. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Elle agit comme une opsonine., Au cours de la réaction inflammatoire, son taux augmente dès la 6ème heure pour atteindre son maximum au bout de 24 à 48h.

Question 22

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Un homme de 38 ans présente une VS à 35mm à la première heure :

- a. Compte tenu de cette VS, l'existence d'un syndrome inflammatoire est confirmé. ✖
- b. Ce résultat est normal. ✖
- c. La VS est modérément accélérée. ✔
- d. Le patient présente une infection bactérienne. ✖
- e. Une mesure à la deuxième heure n'a pas d'intérêt. ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : La VS est modérément accélérée.

Question 23

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

L'inflammation :

- a. fait intervenir des médiateurs chimiques locaux et généraux. ✔
- b. est toujours de cause infectieuse. ✖
- c. aboutit habituellement à une réparation tissulaire. ✔
- d. peut favoriser le développement d'une sclérose. ✔
- e. présente la même correspondance morphologique quel que soit le tissu. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : fait intervenir des médiateurs chimiques locaux et généraux., aboutit habituellement à une réparation tissulaire., peut favoriser le développement d'une sclérose.